Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
3ª Vara Cível da Comarca de Abreu e Lima

Avenida Brasil, 635, Timbó, ABREU E LIMA - PE - CEP: 54767-160 - F:(81) 318193692

Processo nº 0001421-79.2023.8.17.2100

AUTOR(A): L. R. F. D. L., LILIANE FERNANDA FELIX DA SILVA

RÉU: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos e etc.,

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE URGÊNCIA** ajuizada por **LUCAS RAFAEL FELIX DE LIMA,** menor impúbere, representado pela sua genitora a Sra. **LILIANE FERNANDA FELIX DA SILVA**, em face da **YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.**
Alega o autor, em síntese, que é associado à operadora ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem deficiência intelectual (DI) e com linguagem funcional prejudicada, sendo-lhe prescrito os tratamentos de acompanhamento pelo método ABA, fisioterapia e psicopedagogia. No entanto, a ré se omite quanto as suas obrigações contratuais, alegando que o autor está sob carência mesmo diante do laudo que conta a necessidade de urgência da realização do tratamento médico.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a autorizar imediatamente o tratamento do menor por equipe multidisciplinar composta pelos tratamentos de psicologia, tudo de forma integrada e nos termos do relatório médico.

No mérito, pleiteou pela confirmação da tutela, condenação da ré em honorários advocatícios, exibição de documentos, inversão do ônus da prova e deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pretendendo provar o alegado juntou aos autos laudo médico (ID 130523981), cartão do plano (ID 130525042), solicitação das terapias (ID 130523969), orçamento (ID 130525043), além de documentos de comprovação pessoal.

A parte ré, devidamente intimada, apresentou manifestação acerca da tutela de urgência (ID 136651845), alegando, em resumo, que não houve pedido de autorização para a operadora e que o contrato estaria em período de carência.
A fim de provar o alegado, juntou aos autos ficha de adesão ao benefício (ID 136651715, ID 136651716), contrato de prestação de serviços de oferta de plano de saúde (ID 136656132), além de documentos de representação empresarial.
A ré apresentou contestação (ID 139205082), alegando, em síntese, que *a negativa de custeio do tratamento médico do Autora se operou no exercício regular do direito da operadora, visto que, o beneficiário estava em período de carência contratual, a qual findará em 30/07/2023, cujas razoes forma tempestivamente apresentadas pela Ré no id. 136651845; superada a carência contratual e legal, cujo prazo já transcorreu, não há pretensão resistida por parte da operadora Ré em ofertar profissionais como fonoaudiologia, fisioterapia, terapeuta ocupacional e acompanhamento psicoterapêutico ao autor; conquanto, o acompanhamento com o profissional de psicopedagogia e acompanhamento terapêutico para apoio ou reforço escolar não são procedimentos médicos e, portanto, ausente de cobertura obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde; A RN 539/2022 da ANS não conferiu direito aos portadores de Transtorno do Espectro Autista à cobertura de tratamento com psicopedagogo e profissional para acompanhamento de reforço escolar; o regulamento da operadora estabelece ainda que a cobertura ofertada pela You Saúde é aquela adstrita ao Rol da ANS; o recente julgado do STJ firmou entendimento pela taxatividade do Rol da ANS*

e as terapias descritas na exordial como Psicopedagogia e Acompanhamento para Reforço Escolar não são procedimentos de cobertura obrigatória; E, por fim, *a operadora possui em sua rede credenciada os profissionais das áreas da saúde aptos a tratar a enfermidade do autor.*
Réplica apresentada (ID 142557340).

A Representante do Ministério Público ofertou parecer favorável ao deferimento da tutela de urgência (ID 148308890), no sentido de que a ré fosse compelida a custear integral e ilimitadamente o tratamento multidisciplinar a que faz jus o infante, nos exatos termos do laudo emitido pelo médico assistente, a quem cabe estabelecer o melhor tratamento, caso a caso.

Foram concedidos ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 130673246) e a tutela de urgência foi deferida (ID 150782011).

Petição do autor alegando o descumprimento da liminar (ID 153291908, ID 154906206, ID 158658839).

Petição da ré informando que estaria cumprindo a liminar, tendo sido realizado pelo autor as terapias com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogia (ID 163418982), na ocasião a ré juntou aos autos relatório (ID 163418983).

Em resposta, o autor afirmou que a ré vem se recusando a realizar o tratamento do menor conforme laudo e liminar judicial, não tendo disponibilizado monitor na escola da criança nem terapias conforme laudo. Ademais, alega que através do documento apresentado pela ré, é possível verificar a carência no fornecimento das terapias que apenas foram parcialmente realizadas a partir do dia 30/01/2024 (ID 163756496). Por fim, requereu o bloqueio de valores a título de multa.

Foi apresentada manifestação pela representante do Ministério Público (ID 165818421), nos seguintes termos: *(...) Pelo exposto, em que pese a urgente necessidade de cumprimento da decisão proferida, em inegável prejuízo ao infante, imprescindível se faz a confirmação da intimação pessoal da executada a fim de que possa incidir a multa aplicada, pelo que REQUER o Parquet, com a máxima urgência, seja diligenciada a devolução da carta precatória expedida há quase 04 (quatro) meses, tudo a fim de verificar se houve o efetivo cumprimento da diligência outrora determinada (e, em caso positivo, a data de sua realização), o que, de certo - e em não havendo a devida comprovação de observância da ordem judicial pela demandada - implicará no acatamento do pleito autoral de majoração das astreintes, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos autos à Promotoria Criminal para ciência e adoção das providências cabíveis.*

Em resposta, o autor alegou que a súmula 410 do STJ, objeto do fundamento do parecer ID 165818421, não seria aplicado ao presente caso, pois a ré é uma pessoa jurídica representada por vários advogados, não havendo necessidade de citação pessoal. Assim, requereu o bloqueio de valores a título de multa e majoração.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa relatar. Fundamento e decido.

A natureza da matéria questionada autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, eis que diante das alegações expendidas e documentos apresentados, prescinde-se da produção de outras provas.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o contrato de plano de saúde se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a pacto tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.

Estabelecida assim a natureza da relação, são aplicáveis os princípios estabelecidos na legislação consumerista, em especial a incidência do princípio da boa-fé objetiva, bem como o reconhecimento da vulnerabilidade dos consumidores e a facilitação de sua defesa, consoante art. 4º, incisos I e III, e art. 6º, inciso VIII, ambos da Lei 8.078/90.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o contrato de plano de saúde tem como objeto o custeio de despesas médico hospitalares do segurado, quando acometido de algum mal à sua saúde, quer mediante pagamento direto dos custos pela seguradora, quer pelo posterior reembolso.

Quanto à indicação do tratamento ou procedimento a ser utilizado, é cediço que deve incumbir ao médico que realiza o acompanhamento do paciente e não à operadora de plano de saúde. Inclusive, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Logo, o fato do tratamento e da técnica solicitados pelo médico não constar do rol da ANS não resulta, por si só, na exclusão da cobertura.

Destaco que qualquer limitação atinente à realização de procedimentos necessários, prescritos por médicos, à efetivação do referido tratamento, quando expressamente indicados, significa, na realidade, exclusão daquele tratamento, configurando-se como abusiva, consoante o artigo 51, "caput", incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, cumpre pontuar, que a exclusão de procedimentos, exames, terapias, tratamentos, deve ser escrita, legível, clara e definida, não se admitindo a exclusão na forma implícita, como bem dispõe o artigo 54, § 4º, do CDC: *As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.*

No mais, apesar dos julgamentos recentes sobre o tema (C. 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, datado em 08/06/2022; EREsp 1886929 e EREsp 1889704), que decidiram, sem caráter vinculante, que o rol de procedimentos da saúde suplementar seria, em regra, taxativo, na data de 23/06/2022 sobreveio a edição da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, com o seguinte texto: *Altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para* ***regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento****. (grifei)*

Assim, com a Resolução Normativa acima referida, o art. 6º, da RN nº 465/2021, passou a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

> *§ 4º. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.*

Ademais, a ANS editou o Comunicado 95/2022 sobre o tema. Vejamos:

> *A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do art. 55, da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI nº 33910.019120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo os beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CIDs que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura.*

Logo, verifica-se que com a publicação da Lei 14.454/2022, que estabelece critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, o conceito de “rol taxativo” ficou flexibilizado, estando a recente instrução da ANS em harmonia com os ditames legais atuais.

Tem-se, assim, que a recente instrução normativa ampliou a cobertura de procedimentos que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando justamente determinar que as operadoras de plano de saúde ofereçam atendimentos por prestadores aptos a executarem os métodos ou as técnicas indicadas pela médica para o tratamento da doença do autor.

Ainda, com o julgamento do IAC n° 0018952-81.2019.8.17.9000, foram fixadas as seguintes teses por este Eg. TJPE:

> *Tese 1.0 – Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários com o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico ou dentista assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, nos termos da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, (com a redação dada pela Resolução da ANS nº 539/2022), inclusive em ambiente escolar e domiciliar, à luz do disposto na Lei nº 12.764/2012 art. 3º, I, III e parágrafo único.*
>
> *Tese 1.1 – Os requisitos necessários para que o profissional de saúde seja considerado especialista nos métodos ABA (análise do comportamento aplicada), BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇAO SENSORIAL, de acordo com o art. 6º da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, deve estar conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais.*
>
> *Tese 1.2 – Comprovada a inaptidão e/ou indisponibilidade da rede credenciada para oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente com TEA – Transtorno do Espectro Autista, cabe o custeio pelo plano de saúde do mesmo tratamento na rede particular, consoante dispõe a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.*
>
> *Tese 1.3 – O reembolso: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada do serviço de saúde na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-lo na rede particular; b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011; c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, na hipótese em que, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento.*
>
> *Tese 1.4. - A negativa de custeio das terapias multidisciplinares de cobertura contratual obrigatória para tratamento do Transtorno do Espectro Autista poderá ensejar reparação por danos morais, mesmo antes da entrada em vigor da Resolução Normativa da ANS nº 539/2022.*
>
> *Tese 2.0 - As terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, quando aplicadas por profissionais da área de saúde, têm obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde.*
>
> *Tese 2.1 - Comprovada a inaptidão e/ou indisponibilidade da rede credenciada para oferecer atendimento por prestador apto a executar as terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, indicadas pelo médico*

assistente para tratar doença ou agravo do paciente com TEA – Transtorno do Espectro Autista, cabe o custeio pelo plano de saúde do mesmo tratamento na rede particular, consoante dispõe a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Tese 2.2 – O reembolso para as terapias especiais de cobertura obrigatória de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada da terapia na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-la na rede particular; b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011; c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento.

Tese 2.3. - A negativa de custeio das terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade de cobertura contratual obrigatória para tratamento do Transtorno do Espectro Autista enseja reparação por danos morais, a partir da entrada em vigor da Resolução Normativa da ANS nº 539/2022, que as regulamentou.

Observo que, em sede de contestação, a ré alega que a negativa inicial de tratamento do autor se deu em virtude da carência legal, mas, após o prazo de carência, teria oferecido os tratamentos prescritos pelo médico que assiste o autor.

No tocante a negativa ocorrida no período de carência, conforme bem pontuado pelo *Parquet*, o fato do autor ser portador do Transtorno do Espectro Autista não pode ser considerado doença preexistente, mas sim, condição pessoal. Diante disso, no caso específico de terapias para autistas, em regra, são consideradas como procedimentos ambulatoriais, sendo válido, dessa forma, o prazo máximo de carência de 180 dias estabelecido pela ANS para esse tipo de serviço.

Reconheço, ainda, que não houve a comprovação, pelo autor, de evidente emergência ou urgência apta a atrair a obrigatoriedade de atendimento em prazo excepcional previsto no art. 12 da Lei nº 9.656 de 1998. Assim, concluo que não houve ilegalidade da operadora de plano de saúde naquele momento inicial.

No entanto, é fato incontroverso que o prazo de carência se esgotou em 30 de julho de 2023, logo, deveria a ré ter oferecido, integralmente, os tratamentos prescritos pelo médico que acompanha o autor.

Acontece que, em sede de contestação, a ré alegou que a cobertura ofertada é limitada ao rol da ANS, o que não deve ser acolhido. Conforme fundamentado nas linhas anteriores, deve-se seguir a indicação realizada pelo médico que assiste o autor, em conjunto com demais terapias, tendo em vista que o médico tem melhores condições de analisar o caso, pois acompanhou o histórico do paciente. Sendo assim, não se deve interferir na dinâmica multiprofissional do tratamento indicado, que gira em torno especificamente da doença que acomete o autor, com justificativa técnica nesse sentido. Por esse motivo, a condenação da ré em custear o tratamento multiprofissional, nos termos da prescrição médica, é medida que se impõe.

Em relação à negativa da psicopedagogia e acompanhamento terapêutico, insisto que tanto o STJ quanto a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022 impõem o reconhecimento da natureza de taxatividade mitigada ao rol da ANS, devendo, pois, ser oferecido o tratamento indicado pelo médico, que, no presente caso, inclui a psicopedagogia e acompanhamento terapêutico.

Sobre o tema, dispõe o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vejamos:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ***PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA CONTRATUAL DAS TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES, INCLUINDO HIDROTERAPIA E MUSICOTERAPIA. IAC*** *TJPE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO*

UNÂNIME - Tribunal de Justiça de Pernambuco que julgou o Incidente de Assunção de Competência nº 0018952-81.2019.8.17.9000, decidindo, à unanimidade de votos, que é obrigatória a cobertura integral pelos planos de saúde do tratamento multidisciplinar para pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, devendo a cobertura se dar nos moldes prescritos pelos médicos assistentes - Demandada que não demonstrou possuir profissionais habilitados ou clínica apta ao acompanhamento do recorrido, nos moldes das certificações exigidas para o tratamento de TEA. ***Obrigatoriedade de custeio integral do tratamento, incluindo acompanhante terapêutico (AT), musicoterapia, hidroterapia, equoterapia, conforme estabelecido no IAC - Acompanhante especializado em sala de aula que é profissional de educação, atuando junto às crianças especiais introduzidas no contexto escolar, enquanto que o acompanhante terapêutico, na condição de aplicador da ciência ABA, é profissional de saúde, integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento diário do tratamento clínico/terapêutico da criança, em todos os ambientes, inclusive na escola.*** *Obrigatoriedade de cobertura do profissional de saúde. Precedentes - Agravo de instrumento não provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0018161-73.2023.8.17.9000, da Comarca de Recife, em que figuram as partes acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEXTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, voto e ementa que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. Des. Márcio Aguiar Relator*

Fonte: TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0018161-73.2023.8.17.9000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC).

Do acima, é possível verificar que o entendimento deste Tribunal é pela *obrigatoriedade de custeio integral do tratamento, incluindo acompanhante terapêutico (AT), conforme estabelecido no IAC -* ***Acompanhante especializado em sala de aula que é profissional de educação, atuando junto às crianças especiais introduzidas no contexto escolar, enquanto que o acompanhante terapêutico, na condição de aplicador da ciência ABA, é profissional de saúde, integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento diário do tratamento clínico/terapêutico da criança, em todos os ambientes, inclusive na escola. (grifei)***

Ademais, é importante destacar que, de acordo com a Lei Berenice Piana (nº 12.764/12), que estabelece os direitos dos autistas e suas famílias em diversas áreas sociais, todo aluno autista que apresente dificuldades acentuadas de convívio social e manejo comportamental tem direito a um acompanhante especializado em sala de aula. Nesse sentido:

> *Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.*

Portanto, o acompanhamento especializado da criança, mesmo que realizado no ambiente escolar, faz parte de seu tratamento, visa ao seu desenvolvimento em diversos aspectos e é um direito que não pode ser negado.

Nesse ponto, o Enunciado 99, incluído na III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, assim dispõe:

> *Enunciado 99 - O tratamento multiprofissional do transtorno do espectro autista é de cobertura obrigatória por parte das operadoras de saúde, as quais devem viabilizar ao beneficiário ou equipe multiprofissional credenciada pela operadora de saúde, desde que o*

método seja reconhecido pelos respectivos conselhos de classe dos profissionais integrantes da referida equipe multiprofissional, ou que esteja expressamente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

Deve-se também observar que fere o princípio da boa-fé objetiva excluir cobertura de exames, métodos, que possam se tornar indispensáveis ao adequado tratamento do paciente, já que o objetivo do contrato é zelar pela saúde do contratante, levando-se também em consideração que o art. 47, do CDC, disciplina que: *As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.*

Assim, estando o procedimento prescrito por um médico especializado de confiança do autor, a ré tem a obrigação contratualmente assumida de arcar com as despesas para sua realização. A cobertura, portanto, é obrigatória enquanto o contrato estiver vigente, e a negativa da ré configura um ilícito contratual.

Por fim, entendo que assiste razão ao autor acerca da alegação de inaplicabilidade da súmula 410 do STJ ao presente caso, tendo em vista que a providência prevista na referida súmula, de fato, é desnecessária ao presente caso, pois sequer há alegação, por parte da ré, de ausência de intimação da decisão que determinou o cumprimento da obrigação sob pena de multa. Logo, o que se constata é que a ré tinha ciência inequívoca da obrigação que lhe foi imposta por este juízo, posto que fora validamente intimada da decisão que determinou o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, dou por resolvido o mérito deste processo e **JULGO PROCEDENTE** o pleito autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida (ID 150782011) e determinar que a ré autorize integralmente o tratamento indicado ao autor, conforme laudo médico (ID 130523981), com observância da carga horária prescrita, em clínica credenciada especializada no tratamento, ou, na inexistência, que o custeie, de forma integral, em clínica indicada pela autora.

Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Intime-se o autor de que a alegação de descumprimento da tutela e novo pedido de efetivação desta deve ser feito através de cumprimento de sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Em caso de interposição de recurso de embargos de declaração, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo de 5 (cinco) dias, retornando os autos conclusos após decurso do prazo.

Havendo interposição de recurso de apelação, dê-se vistas à parte adversa para contrarrazões e, não havendo recurso adesivo, em seguida, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito, arquive-se independente de nova conclusão.

ABREU E LIMA, 15 de julho de 2024

Juiz(a) de Direito